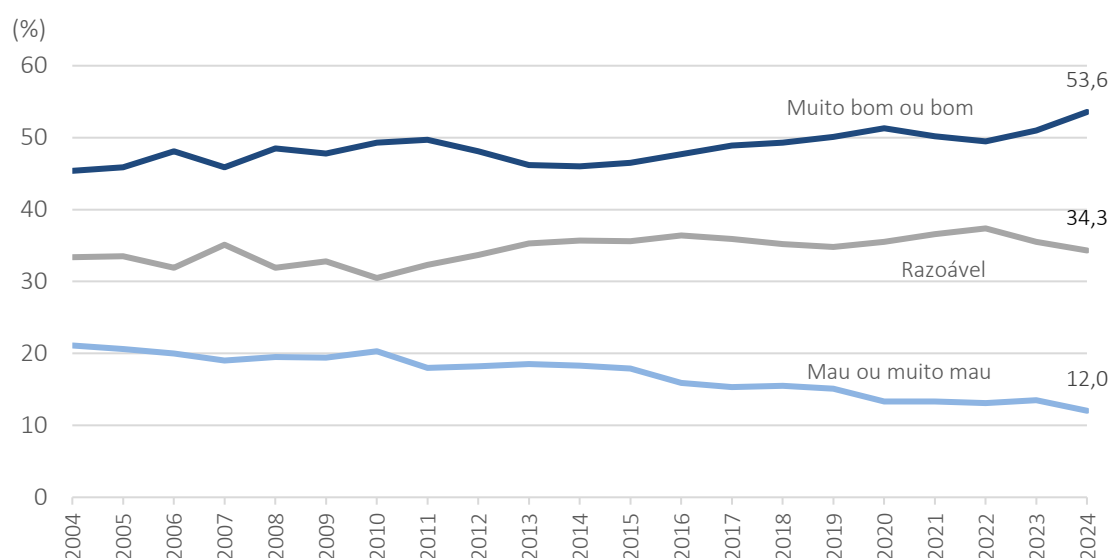


bloco operatório. Os hospitais do setor público também asseguraram a maioria das consultas médicas, mas esta é a componente de atividade em que os hospitais privados conseguiram atingir o peso mais expressivo, representando 39,2% do total.

Mais de 5 em cada 10 pessoas avaliam o seu estado de saúde de forma positiva

Em 2024, 53,6% da população com 16 ou mais anos avaliava o seu estado de saúde como muito bom ou bom, confirmando a evolução ascendente do indicador pelo segundo ano consecutivo e atingindo o valor mais elevado dos últimos 20 anos. Por outro lado, a percentagem de pessoas que avaliava negativamente a sua saúde (12,0% em 2024) foi a mais baixa desde o início da série, representando uma redução de 1,5 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano anterior e significativamente inferior às registadas de 2004 a 2014 (entre 18% e 21%).

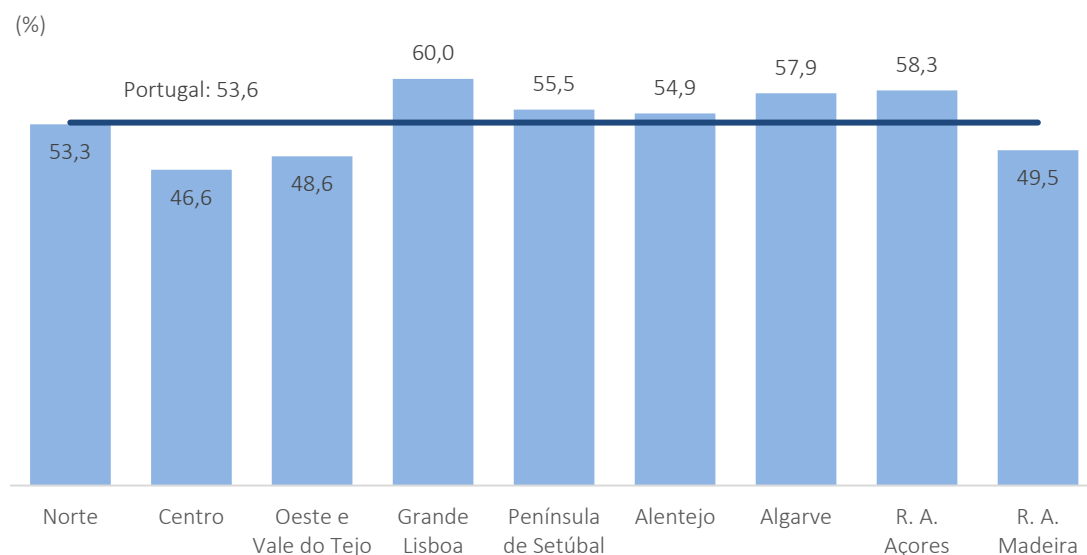
Figura 1. **Proporção da população com 16 ou mais anos por autoapreciação do estado de saúde, Portugal, 2004-2024**



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

Em 2024, a região da Grande Lisboa registava a maior proporção de pessoas com 16 ou mais anos com uma perceção muito boa ou boa do seu estado de saúde (60,0%), seguida da Região Autónoma dos Açores (58,3%) e do Algarve (57,9%). A região Centro registava a frequência mais baixa da população com autoapreciação positiva do seu estado de saúde (46,6%), seguida do Oeste e Vale do Tejo e da Região Autónoma da Madeira, ambas abaixo dos 50%.

Figura 2. **Proporção da população com 16 ou mais anos com autoapreciação do estado de saúde "muito bom ou bom", Portugal e NUTS II, 2024**



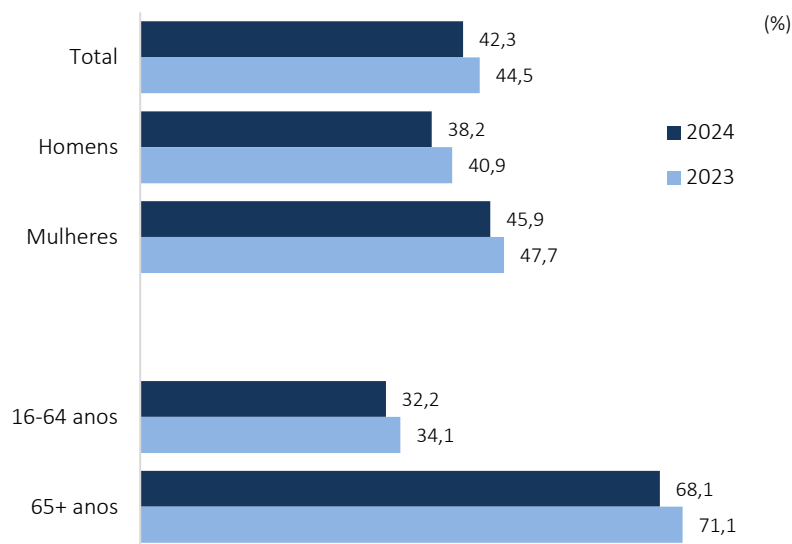
Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

As mulheres e os idosos são os mais afetados pela prevalência da morbilidade crónica

Em 2024, 42,3% da população com 16 ou mais anos referiu ter doença crónica ou problema de saúde prolongado (ou seja, que dura ou pode vir a durar seis ou mais meses), menos 2,2 p.p. do que a proporção reportada no ano anterior (44,5%).

Esta condição era mais frequente nas mulheres (45,9%) do que nos homens (38,2%) e afetava muito mais a população idosa: 68,1% da população com 65 ou mais anos por comparação com 32,2% da população com menos de 65 anos. Em relação ao ano anterior, este indicador registou um decréscimo em ambos os sexos e em ambos os grupos etários.

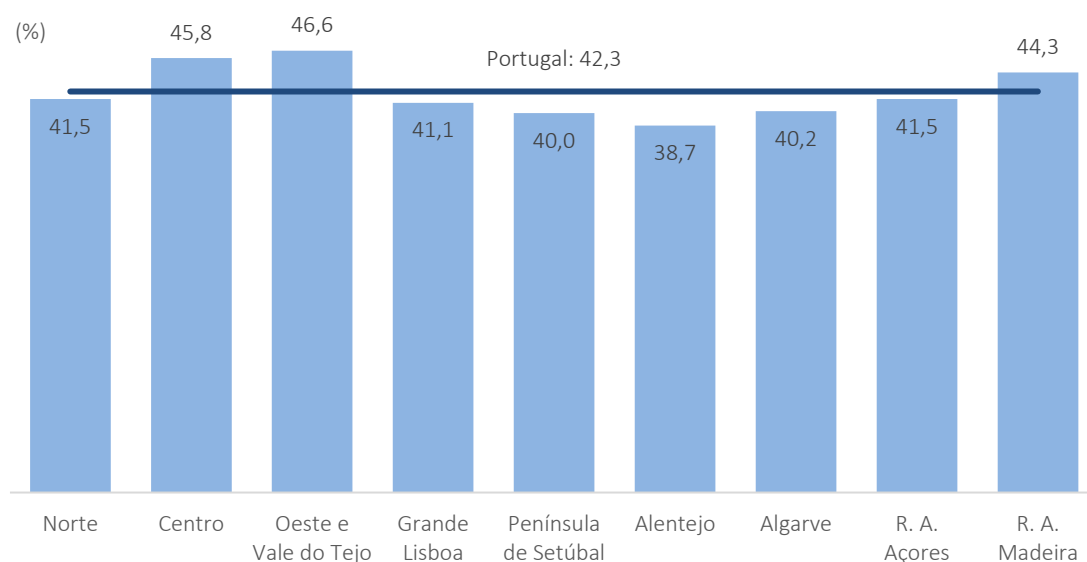
Figura 3. Proporção da população que referiu ter doença crónica ou problema de saúde prolongado, por sexo e grupo etário, Portugal, 2023-2024



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

A prevalência da morbilidade crónica, em 2024, foi maior na região Oeste e Vale do Tejo (46,6%), seguida da do Centro (45,8%) e da Região Autónoma da Madeira (44,3%). As restantes regiões registaram valores abaixo da média nacional (42,3%), em particular o Alentejo (38,7%) e o Algarve e a Península de Setúbal (ambas as regiões com cerca de 40%).

Figura 4. **Proporção da população com 16 ou mais anos que referiu ter doença crónica ou problema de saúde prolongado, Portugal e NUTS II, 2024**



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

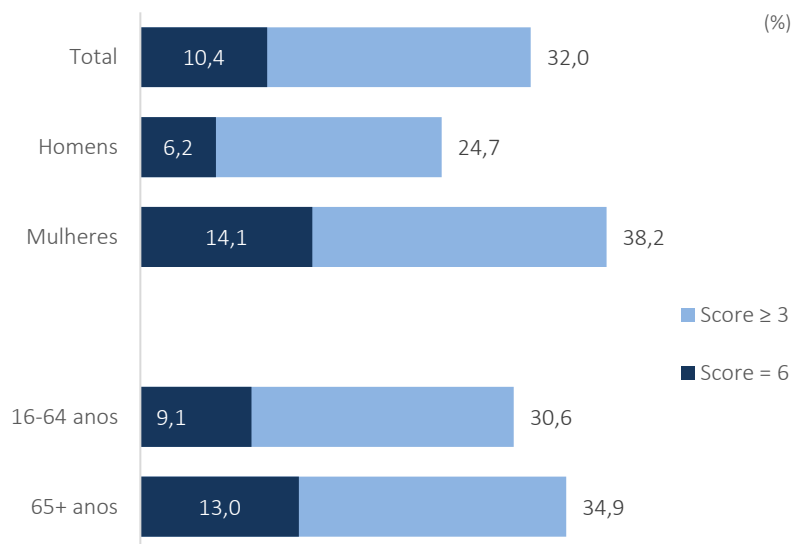
As mulheres são mais afetadas pela condição de ansiedade generalizada do que os homens (em 2 vezes)

Em 2024, 32,0% da população com 16 ou mais anos teria sintomas de ansiedade generalizada, o que corresponde a um score de 3 ou mais pontos, de acordo com o modelo *Generalized Anxiety Disorder 2-item* (GAD-2)¹, e 10,4% revelava níveis de ansiedade mais graves, correspondentes a um score de 6 pontos (score máximo para o modelo adotado).

Esta condição afetava mais as mulheres do que os homens: 38,2% das mulheres, o que compara com 24,7% dos homens, considerando o indicador com o score de 3 ou mais pontos, agravando-se a disparidade para o nível mais grave do indicador (14,1% de mulheres, que compara com 6,2% de homens). O indicador global de transtorno de ansiedade generalizada era também mais elevado no caso da população idosa (mais 4,3 p.p. do que para população dos 15 aos 64 anos).

¹ Versão simplificada do modelo GAD-7 (ver Nota Metodológica).

Figura 5. Proporção da população com 16 ou mais anos com sintomas de ansiedade generalizada (GAD-2), por sexo e grupo etário, Portugal, 2024



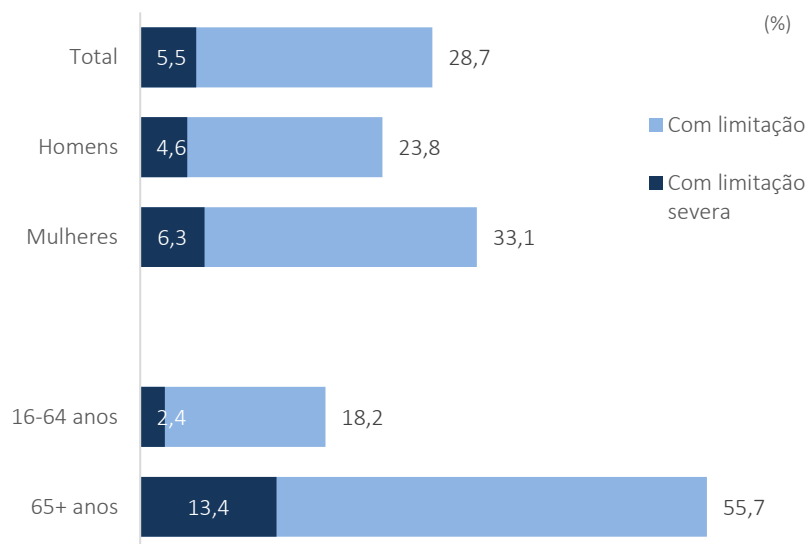
Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

Mais de metade dos idosos referem sentir limitação na realização de atividades devido a problemas de saúde

Em 2024, 28,7% da população com 16 ou mais anos indicou sentir-se limitada na realização de atividades consideradas habituais para a generalidade das pessoas devido a problemas de saúde. Desta, 23,2% referiu sentir limitação, mas não severamente, enquanto 5,5% referiu limitação severa.

As mulheres e os idosos referiram mais frequentemente alguma limitação na realização de atividades (no primeiro caso, 33,1% em relação a 23,8% dos homens; no segundo caso, 55,7%, em relação a 18,2% para a população com menos de 65 anos). A diferença etária era mais evidente na categoria de limitações severas: 13,4% nas pessoas com 65 ou mais anos e 2,4% nas pessoas com menos de 65 anos.

Figura 6. **Proporção da população com limitação na realização de atividades devido a problemas de saúde, por sexo e grupo etário, Portugal, 2024**



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

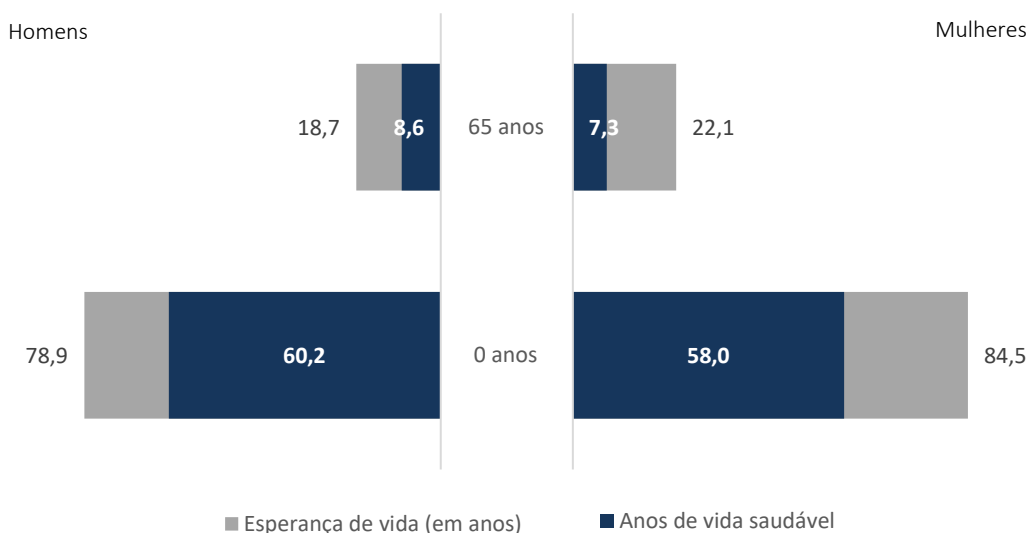
A esperança de vida com saúde é menor para as mulheres

Os resultados do indicador relativo à existência de limitação na realização das atividades habituais são normalmente considerados como uma estimativa da proporção de pessoas com incapacidade e, nessa medida, integrados no cálculo do indicador “Anos de vida saudável”, que permite avaliar se o aumento da esperança de vida é acompanhado ou não de um aumento de tempo vivido em boa saúde. O indicador “Anos de vida saudável” conjuga a morbilidade com a mortalidade, utilizando informação da esperança de vida da população (mortalidade) e as taxas de existência das limitações devido a problemas de saúde (morbilidade).

Em 2022, a esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 84,5 anos para as mulheres e 78,9 anos para os homens. A estimativa de anos de vida saudável à nascença era mais baixa para as mulheres (58,0 anos) do que para os homens (60,2 anos).

No mesmo ano, a esperança de vida aos 65 anos era de 22,1 anos para as mulheres e 18,7 anos para os homens. O ajustamento relativo às limitações devido a problemas de saúde faz diminuir em quase 8 anos a expectativa de uma vida saudável para a população em geral, sendo esta expectativa mais penalizadora para as mulheres (7,3 anos) do que para os homens (8,6 anos).

Figura 7. Esperança de vida e Anos de vida saudável à nascença e aos 65 anos, por sexo, Portugal, 2022



Fonte: Eurostat [hlth_hlye], [demo_mlifetable].

Em 2022, os homens portugueses com 65 anos tinham uma perspetiva de vida saudável superior à das mulheres em 1,3 anos

Em 2022, a esperança de vida em saúde à nascença em Portugal era de 60,2 anos para os homens, menos 2,2 anos do que a média europeia (62,4 anos). No caso das mulheres, a diferença era mais penalizadora: menos 4,8 anos do que a média europeia (58,0 em Portugal e 62,8 anos na UE-27).

Portugal era um dos oito Estados-membros em que a diferença, em relação à média europeia, de anos de vida sem limitações à nascença era superior nos homens, com uma expressão igual à observada para a Suécia. Os Países Baixos registavam a maior diferença em favor dos homens e a Bulgária em favor das mulheres.

No mesmo ano, e por referência à esperança de anos de vida saudável aos 65 anos, Portugal posicionava-se próximo da média europeia no que se refere à população masculina (8,6 anos em Portugal e 8,9 anos na UE-27), mas mais afastado no que se refere às mulheres, com uma diferença de menos 1,9 anos (7,3 anos em Portugal e 9,2 na UE-27). No mesmo ano, Portugal registava a maior diferença em favor dos homens (1,3 anos) e a Bulgária em favor das mulheres (1,7 anos). A média europeia (UE-27) registava uma diferença 0,3 anos entre os sexos, superior para as mulheres.

Figura 8. Anos de vida saudável à nascença e aos 65 anos, por sexo, UE-27, 2022

à nascença				aos 65 anos			
	Homens	Mulheres	Diferença		Homens	Mulheres	Diferença
Bulgária	64,5	68,9	4,4	Bulgária	9,2	10,9	1,7
Lituânia	58,2	62,3	4,1	Eslovénia	10,6	12,2	1,6
Eslovénia	65,0	68,5	3,5	França	10,2	11,7	1,5
Polónia	60,8	64,1	3,3	Lituânia	6,2	7,7	1,5
Estónia	58,0	60,6	2,6	Estónia	7,1	8,1	1,0
Hungria	61,3	63,9	2,6	Hungria	6,6	7,5	0,9
Croácia	59,0	61,5	2,5	Suécia	13,5	14,3	0,8
Letónia	53,0	55,4	2,4	Polónia	7,8	8,6	0,8
Irlanda	65,2	66,8	1,6	Chéquia	7,1	7,7	0,6
Grécia	66,2	67,8	1,6	Irlanda	11,3	11,9	0,6
França	63,7	65,2	1,5	Dinamarca	10,0	10,4	0,4
Eslováquia	56,6	58,0	1,4	Alemanha	8,2	8,6	0,4
Chéquia	61,2	62,4	1,2	Grécia	8,6	9,0	0,4
Itália	67,1	67,8	0,7	Croácia	5,2	5,6	0,4
Áustria	60,6	61,3	0,7	Letónia	4,1	4,4	0,3
Roménia	58,7	59,3	0,6	UE-27	8,9	9,2	0,3
Chipre	65,7	66,3	0,6	Eslováquia	4,7	4,9	0,2
UE-27	62,4	62,8	0,4	Finlândia	8,9	9,1	0,2
Alemanha	60,9	61,2	0,3	Luxemburgo	9,7	9,8	0,1
Malta	70,1	70,3	0,2	Áustria	9,4	9,5	0,1
Bélgica	64,1	63,3	-0,8	Bélgica	10,8	10,8	0,0
Espanha	61,7	60,6	-1,1	Malta	12,2	12,0	-0,2
Luxemburgo	60,7	59,4	-1,3	Roménia	4,0	3,8	-0,2
Portugal	60,2	58,0	-2,2	Chipre	8,8	8,6	-0,2
Suécia	67,5	65,3	-2,2	Espanha	9,8	9,5	-0,3
Dinamarca	57,1	54,6	-2,5	Países Baixos	9,3	8,9	-0,4
Finlândia	59,3	56,5	-2,8	Itália	10,4	9,9	-0,5
Países Baixos	60,7	56,3	-4,4	Portugal	8,6	7,3	-1,3

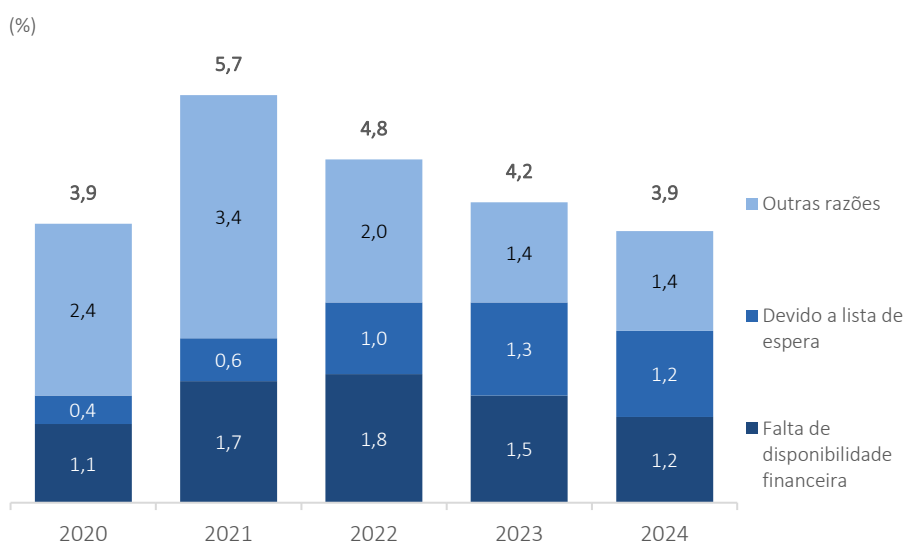
Fonte: Eurostat [hlth_hlye].

10% das pessoas não satisfazem as necessidades de cuidados dentários

Em 2024, 3,9% de pessoas com 16 ou mais anos não conseguiram consulta médica nos 12 meses anteriores à entrevista sempre que necessitaram. Este indicador mantém a tendência descendente que se verifica desde 2022 (menos 1,8 p.p. do que em 2021).

Os motivos apontados repartem-se de modo idêntico entre a falta de disponibilidade financeira e os tempos de espera (1,2%), enquanto 1,4% das pessoas indicaram outros motivos².

Figura 9. **Proporção da população com 16 ou mais anos com necessidade não satisfeita de cuidados médicos nos 12 meses anteriores à entrevista, por principal motivo, Portugal, 2020-2024**



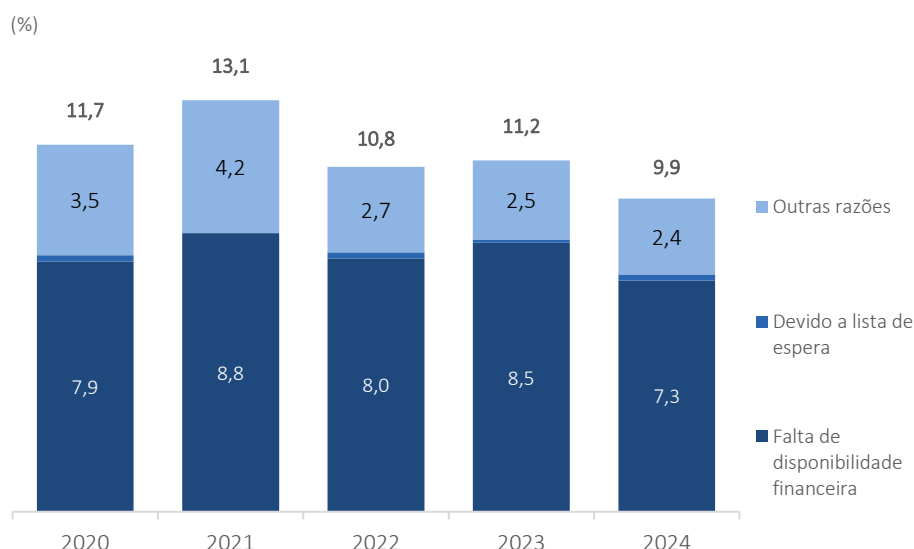
Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

A proporção de pessoas que necessitaram de cuidados dentários nos 12 meses anteriores à entrevista e não puderam satisfazer essa necessidade atingiu, em 2024, o valor mais baixo dos últimos cinco anos, afetando ainda assim 9,9% da população com 16 ou mais anos.

A falta de disponibilidade financeira foi o principal motivo apontado pela população em todo o período em análise. Em 2024, este motivo representou quase $\frac{1}{4}$ dos indivíduos com necessidades não satisfeitas de cuidados dentários.

² Entre as outras razões, para além da disponibilidade financeira e dos tempos de espera, consideram-se a falta de tempo (devido a atividades profissionais, domésticas ou outras), a distância (demasiado longe ou por falta de transporte), o receio de médicos, hospitais, tratamentos, etc., a decisão de aguardar para ver se o problema melhora, ou não conhecer um bom médico/dentista, entre outras; em 2021, foi também incluído o motivo relacionado com a pandemia COVID-19.

Figura 10. **Proporção da população com 16 ou mais anos com necessidade não satisfeita de cuidados dentários nos 12 meses anteriores à entrevista, por principal motivo, Portugal, 2020-2024**



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

A prevalência da insegurança alimentar diminuiu em 2024

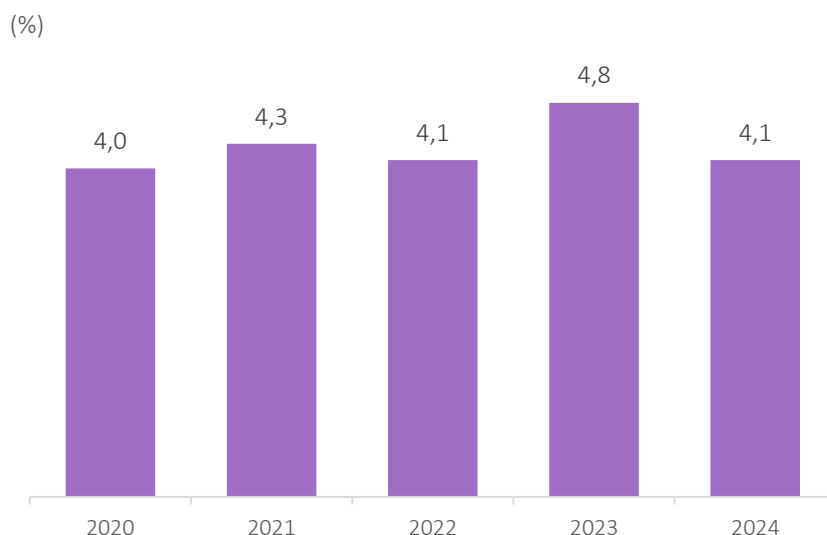
O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento permite ainda aferir a prevalência da insegurança alimentar na população, recorrendo a um indicador baseado na escala da insegurança alimentar (FIES)³ que contribui para a monitorização do progresso no acesso a alimentos suficientes, seguros e nutritivos pela população.

Em 2024, a proporção da população residente em Portugal que se encontrava em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, com uma dieta alimentar de baixa qualidade ou com redução da quantidade de alimentos algumas vezes durante o ano atingiu 4,1%, menos 0,7 p.p. do que em 2023.

A insuficiência alimentar grave, ou seja, a situação em que as pessoas passam vários dias sem se alimentarem devido à falta de recursos, financeiros ou outros, para obter alimentos afetava cerca de 0,5% da população em 2024.

³ Food Insecurity Experience Scale (ver Nota Metodológica).

Figura 11. Taxa de prevalência da insegurança alimentar moderada ou severa da população residente, Portugal, 2020-2024



Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

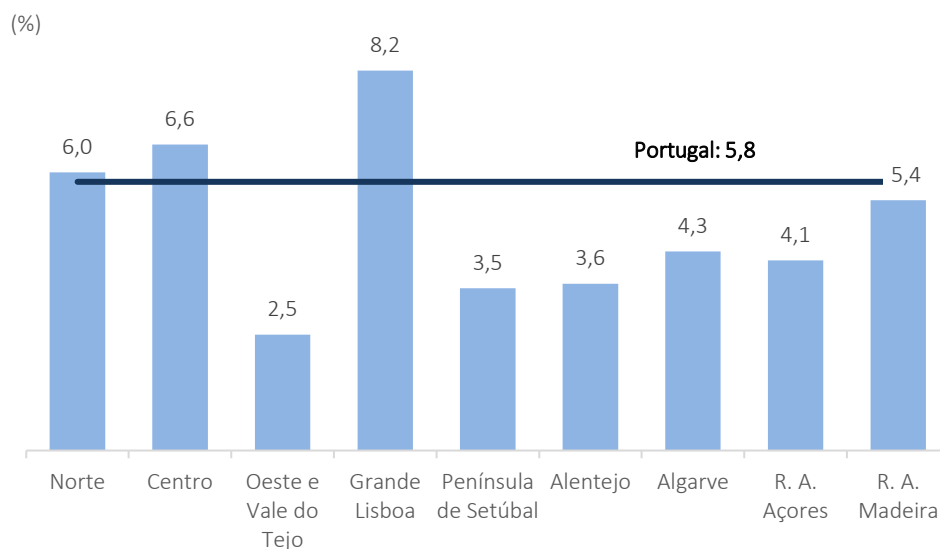
O número de médicos manteve-se em 5,8 por mil habitantes em 2023

Em 2023, estavam inscritos na Ordem dos Médicos 62 132 profissionais, dos quais 59 773 no Continente, 984 na Região Autónoma dos Açores e 1 375 na Região Autónoma da Madeira. Naquele ano, existiam 5,8 médicos inscritos por 1 000 habitantes, o mesmo número de 2022.

Mais de metade dos médicos em 2023 (57,8%) eram mulheres e 49,6% tinham idades dos 31 aos 60 anos. O número de médicos com idades até aos 30 anos (10 239, menos 0,8% do que no ano anterior) era superior ao daqueles com 61 a 65 anos (4 822, menos 7,8% do que em 2022). Retrocedendo até 2013, regista-se uma quebra de 8,0 p.p. na proporção de médicos com idades dos 30 aos 61 anos (de 57,6% em 2013 para 49,6% em 2023), acompanhada pelo aumento da proporção daqueles com mais de 65 anos (de 13,8% em 2013 para 26,2% em 2023). No mesmo período, diminuíram as proporções de médicos com idade até 30 anos, de 17,6% para 16,5%, e de médicos dos 61 aos 65 anos, de 11,0% para 7,8%.

35,7% dos médicos residiam na região Norte e 28,1% na região da Grande Lisboa. O número de médicos por mil habitantes era mais elevado na região da Grande Lisboa (8,2 médicos por mil habitantes) e mais baixo no Oeste e Vale do Tejo (2,5 médicos por mil habitantes).

Figura 12. Número de médicos inscritos na Ordem dos Médicos por 1 000 habitantes, NUTS II, 2023



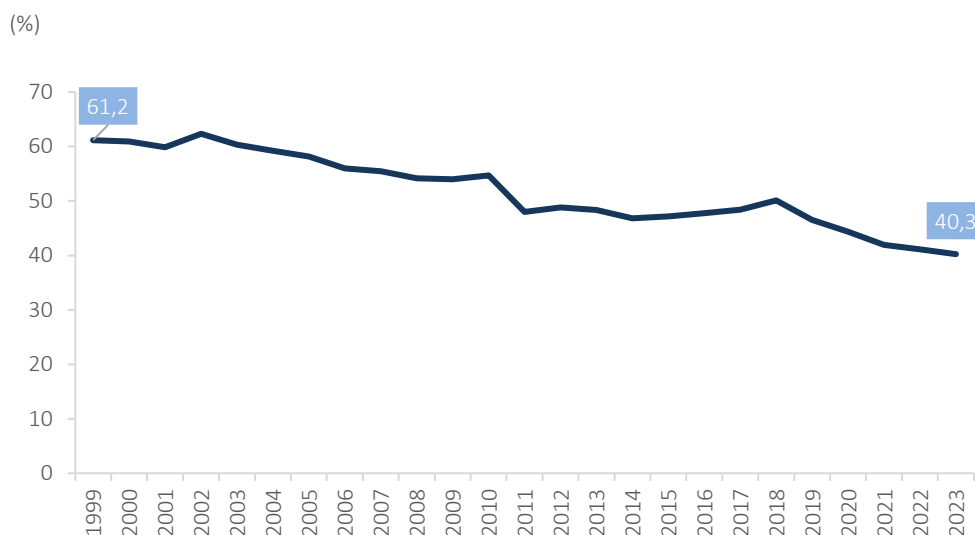
Fonte: INE, Pessoal de Saúde.

Do total de 62 132 médicos inscritos na Ordem dos Médicos em 2023, mais de 60% eram especialistas (38 385), ou seja, estavam habilitados a exercer pelo menos uma especialidade em Medicina. Em 2023, a Medicina Geral e Familiar, a Medicina Interna, a Pediatria e a Anestesiologia continuavam a ser as especialidades detidas por um maior número de médicos especialistas.

Nesse ano, existiam 6,0 especialistas em Medicina Geral e Familiar por 1 000 habitantes com 16 ou mais anos e 0,3 especialistas em Pediatria por 1 000 habitantes com menos de 16 anos. Entre 2000 e 2023, o número de especialistas em Medicina Geral e Familiar quase duplicou e o número de especialistas em Pediatria aumentou 82,6% (respetivamente, 3,0% e 2,9% em média ao ano).

Em 2023, 40,3% (25 016) do total de médicos inscritos na Ordem dos Médicos trabalhavam num hospital, menos 0,9 p.p. do que em 2022. A proporção de médicos a trabalhar nos hospitais tem vindo a diminuir nos últimos 24 anos: em 1999 representavam 61,2%.

Figura 13. **Proporção de médicos a trabalhar em hospitais portugueses, Portugal, 1999-2023**



Fontes: INE, Inquérito aos Hospitais; INE, Pessoal de saúde.

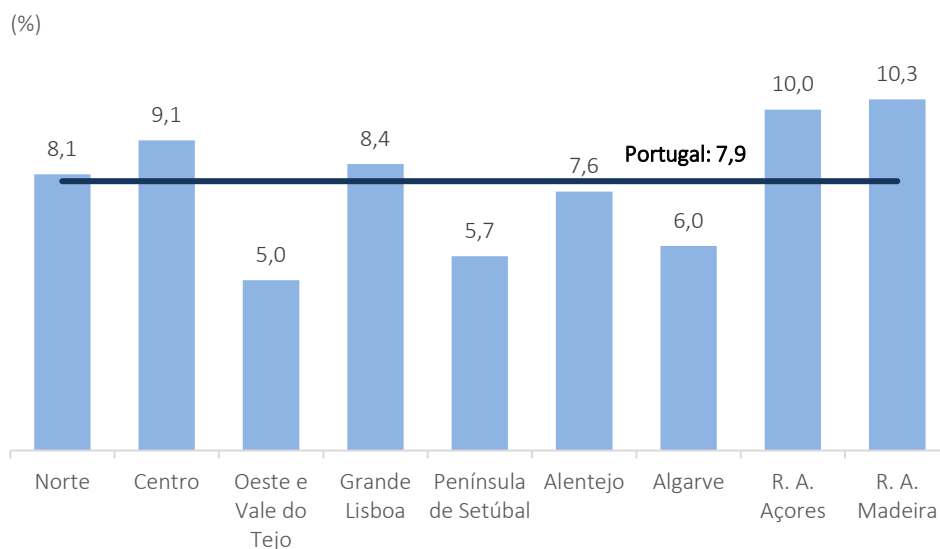
O número de enfermeiros manteve a tendência de crescimento anual

Em 2023, estavam inscritos na Ordem dos Enfermeiros 83 538 profissionais, o que corresponde a 7,9 enfermeiros por 1 000 habitantes, mais 0,1 enfermeiros do que em 2022.

O número de enfermeiros aumentou 2,1% entre 2022 e 2023, não seguindo a tendência de aumento anual, de 2,8%, em média, que se tinha verificado desde 2017.

De acordo com a repartição por local de atividade, 35,5% dos enfermeiros encontravam-se na região Norte, 21,4% na Grande Lisboa e 18,5% no Centro. O número de enfermeiros por mil habitantes era mais elevado nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (10,3 e 10,0 enfermeiros por mil habitantes, respetivamente) e menor no Oeste e Vale do Tejo (5,0).

Figura 14. Número de enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros por 1 000 habitantes, NUTS II, 2023

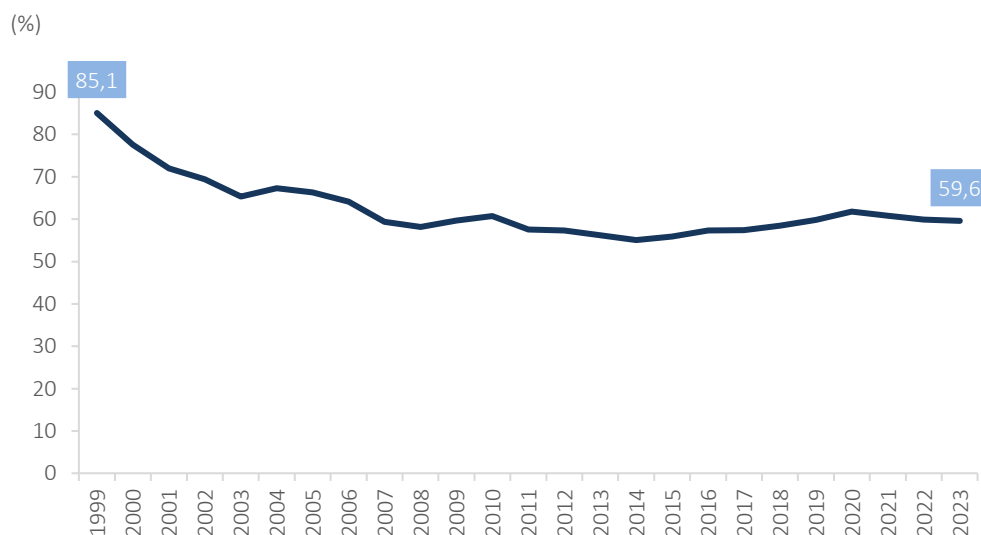


Fonte: INE, Pessoal de Saúde.

Do total de enfermeiros em atividade em 2023, 59 085 eram generalistas (70,7%) e 24 453 eram especialistas (29,3%), com predominância de especialistas em enfermagem de reabilitação (21,6%) e enfermagem médico-cirúrgica (20,8%).

Mais de metade dos enfermeiros trabalhavam num hospital em Portugal em 2023: 49 759, o que equivale a 59,6% do total de enfermeiros inscritos em 2023, menos 0,3 p.p. do que em 2022 e mais 4,5 p.p. do que em 2014. A proporção de enfermeiros a trabalhar nos hospitais diminuiu de forma generalizada até 2014 (de 85,1% em 1999 para 55,1% em 2014), seguindo-se um período de crescimentos anuais entre 2015 e 2020 e uma diminuição daí em diante, de 61,8% em 2020 para 59,6% em 2023.

Figura 15. Proporção de enfermeiros a trabalhar em hospitais portugueses, Portugal, 1999-2023



Fontes: INE, Inquérito aos Hospitais; INE, Pessoal de saúde.

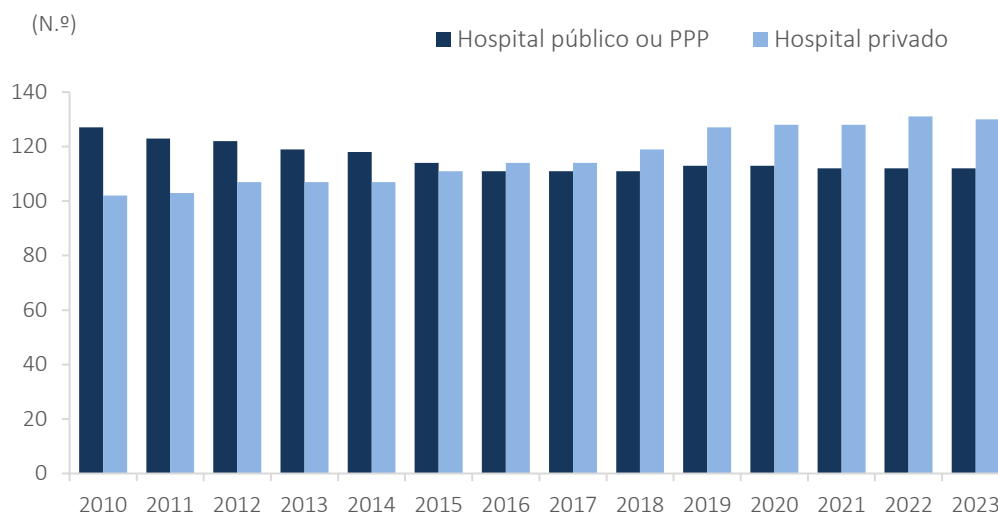
Apesar do crescimento do número de enfermeiros ao serviço ter sido superior nos hospitais privados, foram os hospitais públicos ou em parceria público-privada que mais contribuíram para o crescimento do emprego dos enfermeiros entre 2015 e 2023 (79,8% do aumento global).

35,7 mil camas de internamento em 2023

Em 2023, existiam 242 hospitais em Portugal, 112 dos quais pertencentes aos serviços públicos de saúde. O número de hospitais do setor público em funcionamento tem permanecido relativamente estável desde 2016, mas houve uma diminuição de 15 hospitais em relação a 2010. O rácio dos hospitais de acesso universal por 100 mil habitantes era de 1,1 em 2023, tal como no ano anterior.

Em 2023, estavam em funcionamento 130 hospitais privados, mais 28 do que em 2010. A predominância numérica dos hospitais privados iniciou-se em 2016 e abrange o Continente e as Regiões Autónomas.

Figura 16. Hospitais segundo a natureza institucional, Portugal, 2010-2023



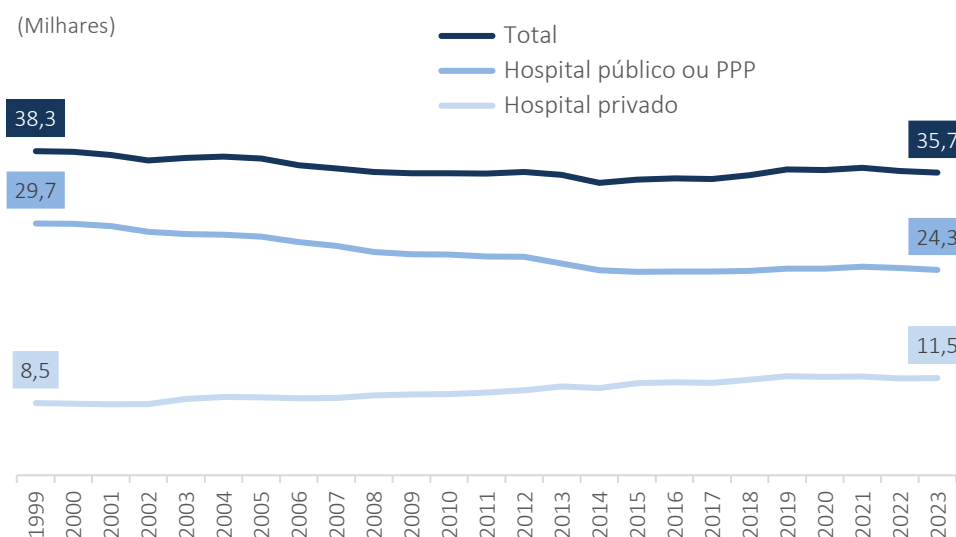
Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, dados provisórios para 2022 e 2023.

Cerca de 75% dos hospitais existentes em 2023 eram hospitais gerais, ou seja, integravam mais do que uma valência. Entre os 59 hospitais especializados, mantinha-se a predominância da Psiquiatria (23 hospitais).

Em 2023, existiam nos hospitais 35,7 mil camas disponíveis e apetrechadas para internamento imediato, menos 211 camas do que no ano 2022 e o correspondente a 3,4 camas de internamento por 1 000 habitantes. Do total de camas, 67,9% estavam em hospitais públicos ou em parceria público-privada (PPP).

Em relação ao início da série, em 1999, assistiu-se a uma redução no número total de camas de internamento nos hospitais portugueses (menos 2,5 mil camas, o equivalente a menos 6,7%) causada principalmente pela evolução nos hospitais públicos ou em parceria público-privada (menos 5,5 mil camas, o equivalente a menos 18,4%). Em contrapartida, entre 1999 e 2023 registou-se um acréscimo de 2,9 mil camas de internamento nos hospitais privados (mais 34,4%).

Figura 17. Camas de internamento dos hospitais segundo a natureza institucional, Portugal, 1999-2023



Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, dados provisórios para 2022 e 2023.

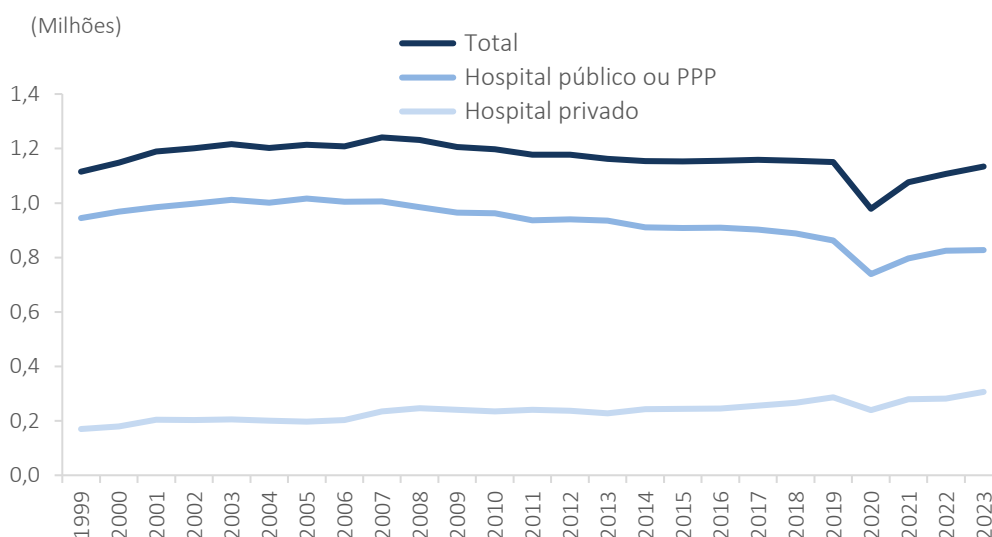
1,1 milhões de internamentos e 10,1 milhões de dias de internamento

Em 2023, registaram-se cerca de 1,1 milhões de internamentos nos hospitais portugueses e 10,1 milhões de dias de internamento. Depois de em 2020 terem sido registados os valores mais baixos da série iniciada em 1999, o número de internamentos em 2023 voltou a ultrapassar 1 milhão e o número de dias de internamento ultrapassou os 10 milhões, tendo ocorrido mais 27,5 mil internamentos e menos 36,2 mil dias de internamento do que no ano 2022 (mais 2,5% e menos 0,4%, respetivamente).

Em 2023, os hospitais públicos ou em parceria público-privada asseguraram cerca de 828 mil internamentos (73,0% do total) e 7,3 milhões de dias de internamento (71,9% do total). Estes valores significam um reforço de aproximadamente 3 mil internamentos e menos 123 mil dias de internamento, o equivalente a mais 0,4% e a menos 1,7% em comparação com a atividade registada em 2022. Nos hospitais privados foram efetuados cerca de 307 mil internamentos que originaram 2,8 milhões de dias de permanência, ou seja, cerca de mais 25 mil internamentos (+8,7%) e mais 87 mil dias de internamento (+3,2%).

Do total de internamentos ocorridos em 2023, 74,9% ocuparam camas de enfermaria, com especial relevo nas especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral e Ginecologia-Obstetrícia, respetivamente com 25,0%, 14,6% e 12,1% do total de internamentos em enfermarias. No caso dos hospitais públicos e em parceria público-privada, estas foram as três especialidades com percentagens mais expressivas, mas no caso dos hospitais privados destaca-se o internamento em camas de enfermaria das especialidades de Ortopedia (18,5%) e de Psiquiatria (12,0%).

Figura 18. Internamentos segundo a natureza institucional, Portugal, 1999-2023



Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, dados provisórios para 2022 e 2023.

No ano de 2023, os doentes permaneceram internados nos hospitais portugueses, em média, 8,9 dias, menos 0,2 dias do que em 2022. Nos hospitais públicos e em parceria público-privada a estada média situou-se igualmente em 8,9 dias (8,8 em 2022), enquanto nos hospitais privados o tempo médio de internamento foi de 9,0 dias (10,1 dias em 2022).

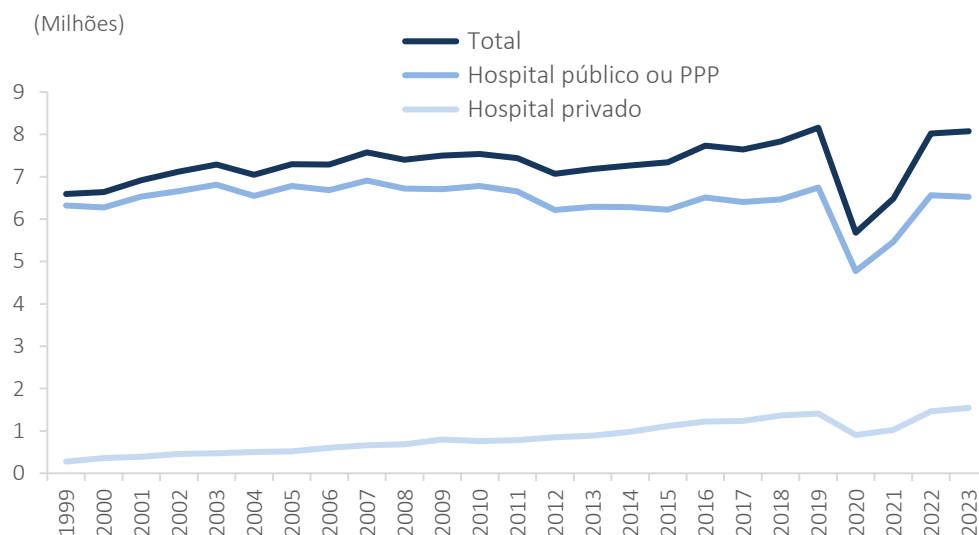
Mais de 8 milhões de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais

Em 2023, realizaram-se cerca de 8,1 milhões de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais portugueses, mais 48,1 mil atendimentos do que em 2022 (+0,6%). A recuperação observada a partir de 2022 permitiu uma aproximação ao nível anterior a 2020, ano em que os atendimentos realizados na urgência hospitalar diminuíram 30,3% e atingiram o valor mais baixo da série iniciada em 1999.

Nos hospitais do setor público, realizaram-se 6,5 milhões de atendimentos em 2023, o que representa menos 37,2 mil atendimentos comparativamente a 2022 (-0,6%). Nos hospitais privados, foram feitos 1,5 milhões de atendimentos em 2023, mais 85,3 mil do que no ano precedente (+5,8%) e o número mais elevado desde 1999.

Os hospitais públicos ou em parceria público-privada realizaram 80,8% do total dos atendimentos em serviços de urgência (81,8% em 2022 e 95,8% em 1999) e os hospitais privados 19,2% (18,2% em 2022 e 4,2% em 1999).

Figura 19. **Atendimentos em serviço de urgência segundo a natureza institucional, Portugal, 1999-2023**

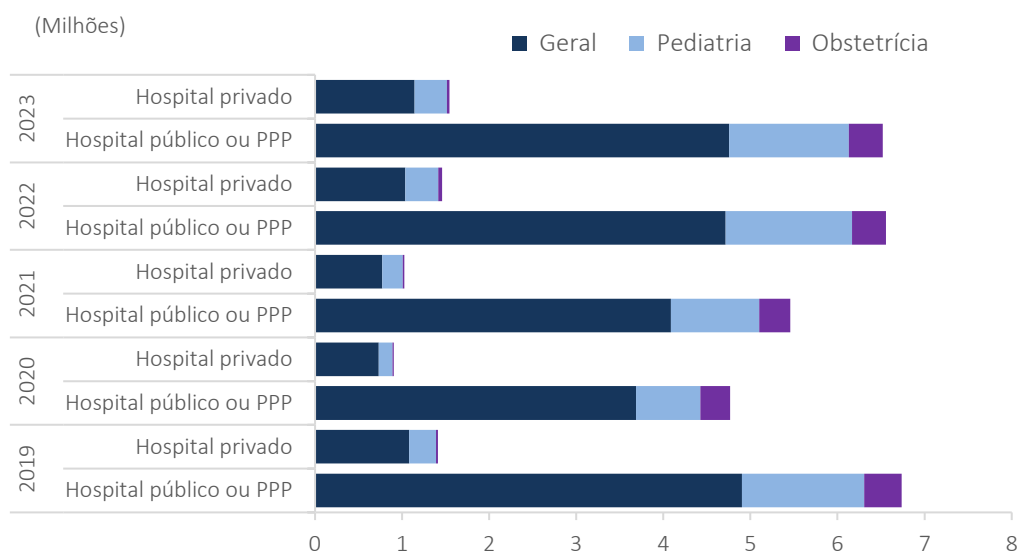


Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, dados provisórios para 2022 e 2023.

A grande maioria dos atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais em 2023 foi assegurada pela urgência geral (73,1%), enquanto a Pediatria e a Obstetrícia asseguraram, respetivamente, 21,6% e 5,2% dos atendimentos.

A urgência geral registou um acréscimo de 2,5% em relação ao ano anterior. No total, em 2023 foram efetuados 5,9 milhões de atendimentos na urgência geral dos hospitais portugueses, o que representa mais 146,4 mil atendimentos do que no ano anterior. Destes 146,4 mil atendimentos a mais, 106,8 mil foram efetuados em hospitais privados e 39,7 mil em hospitais do setor público, o que corresponde respetivamente a aumentos de 10,3% e de 0,8% em relação a 2022.

Figura 20. **Atendimentos em serviço de urgência segundo o tipo de urgência, Portugal, 2019 a 2023**



Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, dados provisórios para 2022 e 2023.

O número de consultas médicas em meio hospitalar atingiu novo máximo

Em 2023, foram efetuadas 23,1 milhões de consultas médicas nas unidades de consulta externa dos hospitais portugueses, mais 1,2 milhões de consultas (+5,3%) do que no ano anterior. Este reforço nas consultas médicas realizadas em contexto hospitalar permitiu ultrapassar o número pré-pandemia COVID-19 e alcançar o valor mais elevado da série iniciada em 1999.

Em comparação com o ano 2022, os hospitais públicos ou em parceria público-privada realizaram mais 469,8 mil consultas médicas (+3,5%), tendo assegurado 60,8% do total de consultas efetuadas nas unidades de consulta externa dos hospitais portuguesas (84,4% em 1999). Os hospitais do setor privado efetuaram mais 689,9 mil consultas médicas (+8,2%), concentrando 39,2% das consultas médicas realizadas nos hospitais portugueses (15,6% em 1999). Esta é a vertente assistencial em que os hospitais privados conseguiram alcançar a percentagem mais elevada do total.



Nos hospitais do setor público foram efetuadas 838,4 mil cirurgias em sala operatória, o que representa um acréscimo de 7,4% em relação ao ano anterior. Nos hospitais privados foram realizadas 333,0 mil cirurgias desta natureza, o que representa um acréscimo de 7,2%.

As especialidades de Oftalmologia, de Ortopedia, de Cirurgia Geral e de Otorrinolaringologia foram as que registaram os maiores aumentos no número de cirurgias realizadas em bloco operatório, tendo conjuntamente assegurado mais 46,6 mil cirurgias (58,0% do aumento verificado entre 2022 e 2023 no total de cirurgias). Os hospitais do setor público foram os que mais contribuíram para o reforço de atividade nas especialidades de Oftalmologia, de Ortopedia e de Cirurgia Geral, enquanto o acréscimo verificado nas cirurgias de Otorrinolaringologia resulta mais da atividade dos hospitais privados.

Cerca de 72% das cirurgias em bloco operatório tiveram lugar em hospitais públicos ou em parceria público-privada, das quais 87,1% foram programadas, ou seja, resultaram de admissões com marcação prévia. No caso dos hospitais privados, as cirurgias programadas tiveram um peso maior, representando 96,2% do total.

Em 2023, foram efetuadas 182,0 mil pequenas cirurgias nos hospitais portugueses, 115,4 mil das quais (63,4%) realizadas em hospitais do setor público. O número total de pequenas cirurgias realizadas em 2023 diminuiu em relação ao ano anterior (menos 774, o correspondente a menos 0,4%).

Mais de 210 milhões de atos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica realizados pelos hospitais

Em 2023, realizaram-se 210,7 milhões de atos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica nos hospitais portugueses, isto é, exames necessários para um diagnóstico (análises laboratoriais, exames imagiológicos, endoscopias, biópsias e outros) ou atos destinados à prestação de cuidados curativos após o diagnóstico e a prescrição terapêutica (fisioterapia, radioterapia, litotricia, imunohemoterapia e outros).

Aquele número reflete um aumento de 3,4 milhões de atos complementares (+1,6%) em relação a 2022 e constitui o máximo observado no período de 1999 a 2023.

Os três principais atos complementares realizados nos hospitais registaram aumentos em 2023. No total, foram efetuadas 138,0 milhões de análises clínicas, 18,1 milhões de atos complementares de Medicina Física e Reabilitação e 14,2 milhões de exames de Radiologia. Estes valores significam mais 408,9 mil análises clínicas, mais 1,3 milhões de atos complementares de Medicina Física e Reabilitação e mais 174,5 mil exames de Radiologia em relação a 2022.

85,1% destes exames ou cuidados curativos foram realizados em hospitais públicos ou em parceria público-privada (94,5% em 1999), enquanto os hospitais privados foram responsáveis pelos restantes 14,9% atos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica realizados no país (5,5% em 1999).



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL

informação à comunicação social

DIÍSTAQUE

O número de medicamentos (marcas) existentes no mercado farmacêutico aumentou em 2023

Em 2023, estavam em atividade em Portugal 2 920 farmácias e 198 postos farmacêuticos móveis, menos uma farmácia do que no ano anterior e mais um posto farmacêutico móvel. O número médio de estabelecimentos farmacêuticos era 29 por 100 mil habitantes.

Ainda em 2023, existiam no mercado farmacêutico 9 023 medicamentos (marcas), a que correspondiam 49 044 apresentações farmacêuticas. Entre 2022 e 2023, o número de medicamentos (marcas) aumentou de 8 935 para 9 023, mas o número de apresentações diminuiu, passando de 49 888 para 49 044.

Cerca de 40% dos medicamentos (marcas) e 18,3% das apresentações existentes foram comparticipados. Em termos de grupos farmacoterapêuticos, mais de metade das apresentações comparticipadas em 2023 respeitavam ao sistema nervoso central (31,3%) e ao aparelho cardiovascular (28,7%).

Mais de metade da despesa corrente em saúde foi financiada pelo SNS e pelos SRS

Entre 2021 e 2023, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas (SRS), em conjunto, foram os principais agentes financiadores da despesa corrente em saúde, suportando, em média, 55,0% do total. Nesses anos, em média, 29,6% da despesa corrente foi suportada diretamente pelas famílias.

Em termos estruturais, entre 2021 e 2023 destaca-se a diminuição do peso relativo da despesa do SNS e dos SRS (54,5% da despesa corrente em 2023, menos 0,5 p.p. do que em 2021) e o aumento de 0,4 p.p. do peso relativo da despesa das famílias.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL

informação à comunicação social

DIÍSTAQUE

NOTA METODOLÓGICA

Inquérito às Condições de Vida e Rendimento

O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento é uma operação estatística realizada anualmente junto de uma amostra representativa das famílias residentes em Portugal, cujo âmbito abrange a valorização das várias fontes de rendimento dos agregados familiares, a sua caracterização socioeconómica e ainda um conjunto extenso de variáveis relativas às condições de vida, de que se destacam neste caso as relativas à saúde. A sua realização permite a divulgação anual dos indicadores estatísticos sobre taxa de risco de pobreza e desigualdade na distribuição dos rendimentos e sobre privação material e habitacional, sendo também a fonte de dados para a atualização anual dos indicadores de base populacional sobre o estado de saúde e para o cálculo dos indicadores relativos à esperança de vida com saúde (anos de vida saudável). Neste âmbito, o inquérito integra o programa harmonizado de estatísticas europeias sobre o rendimento e condições de vida dos agregados domésticos privados, EU-SILC.

Recolhe ainda um conjunto de informação que apenas pode ser fornecida pelo próprio respondente, nomeadamente a opinião sobre o grau de satisfação com a vida em geral; um instrumento de rastreio simplificado para a perturbação de ansiedade generalizada (*Generalized Anxiety Disorder* 2-item, ou GAD-2), composto por duas perguntas que avaliam a probabilidade de perturbação de ansiedade generalizada e outras perturbações de ansiedade nas últimas duas semanas; e uma escala (*Food Insecurity Experience Scale*, ou FIES) de oito perguntas que permitem calcular dois indicadores: um indicador que considera os segmentos da população em insegurança alimentar moderada ou grave.

No modelo GAD-2 (*Generalized Anxiety Disorder* 2-item) a pontuação (score) resulta da soma de ambas. Uma pontuação de 3 pontos é o ponto de corte sugerido para identificar possíveis casos com avaliação diagnóstica adicional para a perturbação de ansiedade generalizada que, no entanto, só por si não é suficiente para diagnosticar, monitorizar o tratamento ou classificar a gravidade.

Os itens que compõem a escala da insegurança alimentar (FIES) foram desenhados para cobrir a gravidade da insegurança alimentar e devem ser analisados em conjunto. Os dados da escala são analisados através da aplicação do modelo *Rasch* e possibilita a base estatística para a medição da segurança alimentar baseada na experiência, produzindo dados sobre insegurança alimentar comparáveis entre países. A escala permite calcular dois indicadores: um indicador que considera os segmentos da população em insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, as pessoas com uma dieta alimentar de baixa qualidade ou com redução da quantidade de alimentos algumas vezes durante o ano; e um segundo indicador que permite estimar a proporção da população que sofre de insegurança alimentar grave, ou seja, as pessoas que passam vários dias sem se alimentarem devido à falta de recursos, financeiros ou outros, para obter alimentos.

Pessoal de saúde inscrito

Os dados de pessoal de saúde inscrito resultam do aproveitamento de dados administrativos para fins estatísticos fornecidos pelas respetivas ordens profissionais. A informação referente a médicos registados na Ordem dos Médicos (ativos ou não) e

DIA MUNDIAL DA SAÚDE – 7 DE ABRIL – 1999-2024



a médicos dentistas registados na Ordem dos Médicos Dentistas (ativos ou não) é disponibilizada geograficamente segundo a residência declarada pelos profissionais de saúde, enquanto a relativa a enfermeiros registados na Ordem dos Enfermeiros (ativos) e a farmacêuticos registados na Ordem dos Farmacêuticos (ativos) é obtida de acordo com o local de atividade dos profissionais de saúde.

Inquérito aos Hospitais

O Inquérito aos Hospitais é uma operação estatística que recolhe dados sobre os equipamentos e instalações, os recursos humanos e a atividade desenvolvida pelos hospitais localizados no Continente e nas Regiões Autónomas. Esta operação estatística foi aplicada pela primeira vez em 1986 (sobre dados de 1985) e, desde então, tem sido realizada anualmente.

Desde 2020 (dados de 2019), integra dados de base administrativa para os hospitais públicos de acesso universal do Continente e dados de inquérito para os hospitais privados e para os hospitais públicos de acesso restrito do Continente, e todos os hospitais, públicos e privados, das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. A utilização dos dados administrativos para fins estatísticos é realizada ao abrigo de um protocolo de cooperação estabelecido entre o Instituto Nacional de Estatística (INE, I.P.), a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, I.P.) e a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, E.P.E.).

Farmácias e medicamentos

Os dados sobre farmácias e medicamentos resultam do aproveitamento de dados administrativos para fins estatísticos fornecidos anualmente pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., para o Continente, e pelos Serviços Regionais de Estatística dos Açores e da Madeira, para as Regiões Autónomas. O INE organiza posteriormente os dados para divulgação.

Conta Satélite da Saúde

A Conta Satélite da Saúde (CSS) tem como objetivo principal avaliar os recursos económicos de um país utilizados na prestação de serviços de cuidados de saúde. De uma maneira geral, procura medir a despesa total em cuidados de saúde, integrando as diferentes dimensões que constituem um Sistema de Saúde Nacional, ou seja, os prestadores de cuidados de saúde, os agentes financiadores e as funções de cuidados de saúde.

CONCEITOS

Anos de vida saudável: Número médio de anos que se espera que um indivíduo de determinada idade venha a viver sem limitações de longa duração para realizar atividades consideradas habituais para a generalidade das pessoas, no pressuposto que se mantém inalterado o padrão de mortalidade observado no período de referência.

Apresentação de um medicamento: Conteúdo de uma embalagem de um medicamento, expresso em número de unidades ou volume de uma forma farmacêutica, em determinada dosagem.



Ato complementar de diagnóstico: Exame ou teste que fornece resultados necessários para o estabelecimento de um diagnóstico.

Ato complementar de terapêutica: Prestação de cuidados curativos, após diagnóstico e prescrição terapêutica.

Autoapreciação do estado de saúde: Apreciação subjetiva que cada pessoa faz da sua saúde.

Cama: Equipamento destinado à estadia de um indivíduo num estabelecimento prestador de cuidados de saúde.

Cirurgia programada: Cirurgia decorrente de admissão programada.

Cirurgia: Um ou mais atos cirúrgicos, com o mesmo objetivo terapêutico e/ou diagnóstico, realizado(s) por médico cirurgião em sala operatória na mesma sessão.

Consulta: Ato em saúde no qual um profissional de saúde avalia a situação clínica de uma pessoa e procede ao planeamento da prestação de cuidados de saúde.

Consulta de especialidade: Consulta médica realizada no âmbito de uma especialidade ou subespecialidade de base hospitalar que deve decorrer de indicação clínica.

Consulta médica: Consulta realizada por um médico.

Doença: Comprometimento do estado normal de um ser vivo que perturba o desempenho das funções vitais, manifesta-se através de sinais e sintomas e é resposta a fatores ambientais, agentes infecciosos específicos, alterações orgânicas ou combinações destes fatores.

Enfermaria: Unidade funcional dos serviços de internamento de um estabelecimento de saúde onde permanecem os doentes e que tem pelo menos três camas.

Enfermeiro: Profissional de saúde qualificado com licenciatura em Enfermagem e autorização da respetiva ordem profissional para o exercício da Enfermagem.

Enfermeiro especialista: Enfermeiro habilitado a exercer uma especialidade em enfermagem.

Especialidade em medicina: Conjunto de conhecimentos e competências específicos, obtidos após a frequência com aproveitamento de formação pós-graduada e que confere especialização numa área particular da medicina.

Esperança de vida à nascença (e0): Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento.

Esperança de vida numa determinada idade (ex): Número médio de anos que uma pessoa que atinja a idade exata x pode esperar ainda viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento.

Estado de saúde: Perfil de saúde de um indivíduo ou população que é objetivável através de um conjunto organizado de indicadores.

Farmácia: Estabelecimento devidamente autorizado a dispensar ao público medicamentos que estejam ou não sujeitos a receita médica.

Grupo etário: Intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo com o momento de referência.



Hospital: Estabelecimento de saúde que presta cuidados de saúde curativos e de reabilitação em internamento e ambulatório, podendo colaborar na prevenção da doença, no ensino e na investigação científica.

Hospital em parceria público-privada: Hospital cujo principal financiador ou tutor administrativo é o Estado e cuja gestão é controlada e efetuada por uma entidade privada por via de um contrato estabelecido com o Estado, podendo ser de acesso universal ou de acesso restrito.

Hospital especializado: Hospital em que predomina um número de camas adstritas a determinada valência ou que presta assistência apenas ou especialmente a utentes de um determinado grupo etário.

Hospital geral: Hospital que integra diversas valências.

Hospital privado: Hospital cujo proprietário e principal financiador é uma entidade privada, com ou sem fins lucrativos, podendo ser de acesso universal ou de acesso restrito.

Hospital público: Hospital cujo proprietário, principal financiador ou tutor administrativo é o Estado, podendo ser de acesso universal ou de acesso restrito.

Incapacidade: Interação da condição de saúde de um indivíduo com os seus fatores contextuais, ambientais e pessoais que revela limitação de atividade e/ou restrição na participação.

Insegurança alimentar: Privação de acesso garantido a quantidade suficiente de alimentos adequados ao normal crescimento e desenvolvimento para uma vida ativa e saudável. Nota: a insegurança alimentar pode ocorrer pela indisponibilidade de alimentos, a incapacidade de aquisição, a distribuição inapropriada ou utilização desadequada dos alimentos ao nível do agregado familiar. A insegurança alimentar pode ser crónica, sazonal ou transitória.

Insegurança alimentar grave: Insegurança alimentar que decorre da ausência de comida total ou por um dia ou dois, da fome extrema.

Insegurança alimentar moderada: Insegurança alimentar que decorre da incerteza em obter alimentos, do risco de faltar às refeições ou os alimentos se esgotarem, de ser forçado a comprometer-se com a qualidade nutricional e/ou a quantidade de alimentos consumidos.

Internamento: Modalidade de prestação de cuidados de saúde a indivíduos que, após admissão num estabelecimento de saúde, ocupam cama (ou berço de neonatologia ou pediatria) para diagnóstico, tratamento ou cuidados paliativos, com permanência de, pelo menos, 24 horas.

Medicamento: Substância ou associação de substâncias que possuem propriedades curativas ou preventivas de doenças e dos seus sinais ou sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as respetivas funções fisiológicas.

Medicina geral e familiar: Especialidade em medicina que se ocupa dos problemas de saúde dos indivíduos e das famílias de forma continuada e no contexto da comunidade.

Médico: Profissional de saúde com licenciatura em medicina e autorização pela respetiva ordem profissional para o exercício da medicina.

Médico especialista: Médico habilitado a exercer uma especialidade em medicina.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE – 7 DE ABRIL – 1999-2024



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL

informação à comunicação social

DIÍSTAQUE

Pequena cirurgia: Cirurgia que, embora executada em condições de segurança e assepsia e com recurso a anestesia local, dispensa a sua realização numa sala de bloco operatório, o apoio direto de um ajudante, a monitorização anestésica e a estadia em recobro, tendo alta imediata após a intervenção.

Posto farmacêutico móvel: Estabelecimento destinado à dispensa ao público de medicamentos e produtos de saúde ao público, a cargo de um farmacêutico e dependente de uma farmácia em cujo alvará se encontra averbado.

Problema de saúde: Problema relacionado com a saúde que suscita a necessidade de prestação de cuidados de saúde.

Problema de saúde prolongado: Problema de saúde que dura ou se prevê vir a durar mais do que seis meses.

Saúde: Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.

Saúde mental: Estado de saúde relacionado com a capacidade do indivíduo realizar o seu próprio potencial, ser capaz de lidar com o stress diário, trabalhar produtivamente e contribuir para a comunidade em que está inserido.

Serviço de urgência: Unidade funcional clínica de um estabelecimento de saúde que presta cuidados de saúde a indivíduos que acedem do exterior com alteração súbita ou agravamento do estado de saúde, a qualquer hora do dia ou da noite durante 24 horas.

Serviço de urgência hospitalar: Serviço de urgência de um hospital dotado de meios físicos, técnicos e humanos especializados, para tratamento de situações de urgência.

Teleconsulta: Consulta realizada à distância com recurso à utilização de comunicações interativas, audiovisuais e de dados (inclui videochamada, telefone móvel ou fixo, correio eletrónico e outros meios digitais), com registo opcional no equipamento e obrigatório no processo clínico do utente.

Tempo de internamento: Total de dias utilizados por todos os doentes internados nos diversos serviços de um estabelecimento de saúde num período de referência, excetuando os dias das altas dos mesmos doentes desse estabelecimento de saúde.

Unidade de consulta externa: Unidade orgânico-funcional de um hospital onde os utentes são atendidos para consulta.